HELP_Organi_P20 — Groupe E — Lots 242 à 246 — 20 questions

Questionnaire de recherche médicale pour l'encyclopédie PROFILES (examen fédéral suisse). Paquet 20 sur 30.

Consignes

1. Tu réponds de façon sourcée, jamais de mémoire. Sources suisses d'abord (OFSP, Swissmedic, AIPS sur swissmedicinfo.ch, Tox Info Suisse, Fedlex, ASSM, FMH, sociétés suisses), puis européennes (ESC, ERS, ERC, EASL, ESCMID, ESE, EULAR, EAACI, KDIGO, EMA). Jamais de recommandation exclusivement américaine.
2. Pour chaque question : recommandation suisse en vigueur (société ou autorité, titre, année, URL) ; version la plus récente comparée à la version citée dans le « Contexte », avec les différences ; informations, doses, posologies, voies et adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'AIPS, avec le numéro d'autorisation Swissmedic ; à défaut de source suisse, la recommandation européenne la plus récente.
3. Chaque réponse a sa propre source et son propre extrait mot pour mot, avec URL et date de consultation. Les formules « idem », « voir question X » ou une source recopiée sans extrait propre sont interdites.
4. Si aucune source fiable n'existe, écris « donnée non trouvée dans les sources consultées » et liste les sources consultées. N'invente jamais.
5. Au début, écris le nombre de questions reçues dans ce paquet. À la fin, rends exactement le même nombre de réponses, avec leurs numéros.
6. Fais ensuite auditer ce paquet par un agent distinct, en raisonnement élevé : URL existante, extrait présent dans la source, source suisse ou européenne la plus récente, dose conforme à l'AIPS. Il corrige ou marque « donnée non trouvée ». Il n'invente jamais.
7. Rends les réponses dans un Google Doc du dossier HELP nommé comme ce paquet, suivi de « _REPONSES ». Écris en français, en phrases verbales courtes.

Questions

E-002 — Haute — LOT 242 · SSP O7.20

Emplacement : LOT_242_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_242_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html ; LOT_242_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc 1 › point 2 › fenêtre « SwissPOD et enquête suisse sur la santé 2022 » ; Partie 1 › DX.1 et DX.2 › 2.1 entonnoir SwissPOD et 11.A- But ; Partie 2 › DX.3 › tableau SwissPOD

Contexte : Le cours cite un consentement de 48,0 % (SwissPOD 2011–2012), 23 % de volonté écrite et 48 % de proches informés (ESS 2022) ; le rapport 2025 qualifie le consentement de « faible » sans chiffre ; aucune cible nationale chiffrée.

Question : Quel est le taux de consentement (et de refus) des proches au don d'organes en Suisse en 2024 et 2025 selon Swisstransplant/CNDO ou l'OFSP (titre, année, URL) ? Quelles cibles chiffrées le plan d'action fédéral « Plus d'organes pour des transplantations » ou l'OFSP fixent-ils pour le consentement et pour la volonté documentée ? Où en est la mise en œuvre du consentement présumé au sens large (révision LTx acceptée le 15 mai 2022 : date d'entrée en vigueur prévue, registre national) ? Donner le chiffre suisse le plus récent (source, année, URL : OFS, OFSP, registre ou rapport national) ; à défaut, le chiffre européen le plus récent avec sa méthode de mesure.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :

4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-004 — Haute — LOT 242 · SSP O7.20

Emplacement : LOT_242_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_242_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc 1 › point 9 (examen de référence) › tableau du test d'apnée ; Bloc 2 › B1 conditionnement du donneur ; Partie 2 › DX.3 › tableau du test d'apnée

Contexte : Le cours donne pH < 7,30 (adulte) et < 7,25 (enfant < 1 an), saturation jamais sous 80 % chez l'enfant, PaCO2 cible 35–40 mmHg chez le donneur ; cible de pH et seuil de saturation absents.

Question : Quels critères de validité du test d'apnée fixent les directives ASSM sur le diagnostic de la mort (version 2017 en vigueur et projet de révision 2025) : PaCO2 cible ou hausse minimale, pH artériel, préoxygénation, saturation minimale et conduite en cas de désaturation chez l'adulte et l'enfant ? Quelle cible de pH accompagne la PaCO2 35–40 mmHg dans le conditionnement du donneur (Swiss Donation Pathway, Swisstransplant/CNDO) ? Citer la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL) ; comparer sa version la plus récente avec celle citée dans le cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-005 — Haute — LOT 242 · SSP O7.20

Emplacement : LOT_242_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_242_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc 1 › 9.d deuxième intention ; Partie 2 › DX.3 › tableau « Interpréter les examens complémentaires de la perfusion cérébrale »

Contexte : Le cours cite pour le Doppler transcrânien couleur des pics systoliques < 50 cm/s ou un signal biphasique ; l'IRM est « appropriée mais fastidieuse » ; critères détaillés de l'IRM et valeurs normales absents.

Question : Quels examens complémentaires de l'arrêt de la perfusion cérébrale les directives ASSM (version en vigueur et révision 2025) acceptent-elles (angio-TC, angiographie, Doppler transcrânien, IRM, scintigraphie), avec leurs critères de positivité exacts, leurs limites et la qualification requise de l'examinateur ? Quels sont les critères IRM retenus ? Citer la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL) ; comparer sa version la plus récente avec celle citée dans le cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-008 — Haute — LOT 242 · SSP O7.20

Emplacement : LOT_242_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Partie 2 › DX.3 › fenêtre 3.1 « diabète insipide » et tableau de ventilation du donneur

Contexte : Le cours retient une diurèse > 3–4 L/j ou > 2,5–3 mL/kg/h, une natrémie > 145 mmol/L avec cible < 155 mmol/L, une pression de plateau > 30 cmH2O ; valeurs de référence absentes.

Question : Quels seuils de diurèse et de natrémie définissent le diabète insipide du donneur et quelles cibles de natrémie, de pression de plateau, de volume courant et de PEEP recommande le protocole suisse de prise en charge du donneur (Swiss Donation Pathway) ou, à défaut, le consensus européen le plus récent ? Citer la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL) ; comparer sa version la plus récente avec celle citée dans le cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-010 — Haute — LOT 242 · SSP O7.20

Emplacement : LOT_242_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_242_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Bloc 1 › B3 prophylaxies anti-infectieuses du greffé (Pneumocystis) ; Partie 4 › DX.8 › 11.B moyens et 1re année

Contexte : Le cours cite Bactrim forte® 800/160 mg 3×/semaine (demi-dose si ClCr 15–30), KDIGO 2009 « ancien, aucune mise à jour trouvée » ; protocoles suisses absents ; 55 % des greffés ont une infection la 1re année (STCS).

Question : Quelles prophylaxies anti-infectieuses (Pneumocystis, CMV selon le statut D/R, antifongique, hépatite B) les centres suisses de transplantation appliquent-ils (STCS, Infectiologie SSI, protocoles publiés, année, URL) : molécule, dose, durée, adaptation rénale ? Quelle est la recommandation européenne la plus récente (ESCMID/ESOT, ECIL, AST 2019 comme comparaison) par rapport à KDIGO 2009 ? Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-011 — Haute — LOT 242 · SSP O7.20

Emplacement : LOT_242_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Partie 4 › DX.8 › tableau d'interprétation (CMV, BK virus)

Contexte : Le cours cite une virémie BK > 10 000 copies/mL (spécificité 93 %) ; seuils de charge virale CMV et sensibilité absents.

Question : Quels seuils de charge virale CMV (UI/mL) déclenchent un traitement préemptif et quels seuils de virémie BK définissent la néphropathie BK présumée, selon les centres suisses (STCS) ou le consensus international le plus récent (Kotton 2018/2024 pour le CMV, AST/ESOT pour le BK) ?

Quelle est la conduite (réduction de l'immunosuppression, valganciclovir : dose curative et adaptation rénale). Citer la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL) ; comparer sa version la plus récente avec celle citée dans le cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-013 — Haute — LOT 242 · SSP O7.20

Emplacement : LOT_242_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Partie 4 › DX.8 › pyélonéphrite du greffon (fenêtre « hospitalisation pour pyélonéphrite du greffon » et critères)

Contexte : Le cours justifie l'hospitalisation et les antibiotiques i.v. ; critères détaillés et agent antibiotique absents.

Question : Quels critères définissent la pyélonéphrite du greffon rénal et quelle antibiothérapie empirique (molécule, dose, durée, relais oral) recommandent les lignes directrices suisses (SSI, guidelines.ch « Infections urinaires ») ou européennes (EAU 2025, ESOT) chez le greffé rénal ? Citer la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL) ; comparer sa version la plus récente avec celle citée dans le cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente. Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-014 — Haute — LOT 242 · SSP O7.20

Emplacement : LOT_242_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Bloc 1 › prévention secondaire et tertiaire du greffé et du donneur

Contexte : Le cours dit que le greffé évite les vaccins vivants, reçoit la grippe dès 1 mois et l'hépatite B (anti-HBs > 10 mUI/mL) ; recommandations suisses non trouvées.

Question : Quelles recommandations suisses de vaccination avant et après transplantation d'organe solide sont en vigueur (OFSP/CFV, « Recommandations de vaccination pour les candidats et receveurs d'une transplantation d'organe solide », année, URL ; Plan de vaccination suisse 2026) : vaccins, calendrier, délais après la greffe, vaccins vivants interdits, sérologies cibles ? Citer la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL) ; comparer sa version la plus récente avec celle citée dans le cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :

3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-017 — Haute — LOT 242 · SSP O7.20

Emplacement : LOT_242_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Partie 2 › DX.3 › préalables du diagnostic (états simulateurs, fenêtre « température centrale »)

Contexte : Le cours cite une température centrale minimale de 35 °C et l'hypothermie < 32 °C comme état simulateur ; hypoglycémie et état de mal non convulsif « non listés par l'ASSM ».

Question : Quels préalables et états simulateurs à exclure avant le diagnostic de mort cérébrale énumèrent les directives ASSM (version en vigueur et révision 2025) : température, pression artérielle, troubles métaboliques et électrolytiques chiffrés, intoxications et sédatifs (délais), place de l'EEG ? Citer la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL) ; comparer sa version la plus récente avec celle citée dans le cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-018 — Haute — LOT 242 · SSP O7.20

Emplacement : LOT_242_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Partie 2 › DX.4 › DCD : catégories (fenêtre « DCD, DBD, DCD contrôlé et non contrôlé »), fenêtres « Hypotension » et « hypoxémie », calendrier de traçabilité

Contexte : Le cours ignore la correspondance uDCD–Maastricht, les seuils d'hypotension et d'hypoxémie qui excluent le don et le délai maximal entre retrait thérapeutique et arrêt circulatoire.

Question : Quels seuils (pression artérielle systolique ou moyenne, saturation) définissent le début de l'ischémie chaude fonctionnelle, quel délai maximal retrait–arrêt circulatoire et quel temps d'observation « no touch » (5 ou 10 min) appliquent les directives ASSM et le protocole DCD suisse (Swisstransplant/CNDO) ? Quelles catégories de Maastricht modifiée (2013) sont pratiquées en Suisse, dont le DCD non contrôlé ? Citer la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL) ; comparer sa version la plus récente avec celle citée dans le cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-019 — Haute — LOT 242 · SSP O7.20

Emplacement : LOT_242_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Partie 2 › DX.4 › tableau « Traitements pharmacologiques liés au DCD » (① analgo-sédation palliative, ③ myorelaxants)

Contexte : Le cours cite les directives ASSM « Attitude face à la fin de vie et à la mort » (2018, adaptées 2021, ch. 6.1.3) sans substances ni doses, et des myorelaxants « recommandés par l'ASSM » sans DCI.

Question : Quelles substances et quels schémas d'analgo-sédation palliative au retrait thérapeutique (opioïde, benzodiazépine, propofol) et quels myorelaxants pendant le prélèvement recommandent les directives ASSM ou le protocole DCD suisse ? Les mesures médicales préliminaires (héparine, etc.) autorisées par la LTx art. 10 et leurs doses ? Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-020 — Haute — LOT 242 · SSP O7.20

Emplacement : LOT_242_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Partie 2 › DX.4 › calendrier de surveillance du receveur de rein (J0–J7) ; Partie 3 › DX.6 › fenêtres « oligurie », « poids et pouls » et tableau d'interprétation (créatinine, C0 tacrolimus, protéinurie)

Contexte : Le cours cite une hausse de créatinine > 25–50 %, une protéinurie ≥ 3,0 g/g ; seuil d'oligurie, calendrier local et seuil inférieur de C0 du tacrolimus absents.

Question : Quelle définition chiffrée de l'oligurie et de la reprise retardée de fonction du greffon, quel calendrier de surveillance précoce (créatinine, diurèse, C0) et quelles cibles de C0 du tacrolimus par période post-greffe (seuil inférieur et supérieur) retiennent les centres suisses ou la recommandation européenne la plus récente (consensus IATDMCT 2019, ERA) ? Citer la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL) ; comparer sa version la plus récente avec celle citée dans le cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-023 — Haute — LOT 242 · SSP O7.20

Emplacement : LOT_242_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_242_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc 1 › fenêtre 9.5 seuils KDIGO du donneur vivant ; Partie 2 › DX.5 › tableaux « Éléments de l'examen » et « Interpréter le DFG, l'albuminurie, la pression et le poids »

Contexte : Le cours applique KDIGO 2017 au donneur vivant (DFG ≥ 90 accepter, < 60 refuser ; albuminurie < 30 / > 100 mg/j ; IMC > 30 kg/m²).

Question : Quels critères d'acceptation du donneur vivant de rein (DFG, albuminurie, pression artérielle, IMC, glycémie) appliquent les centres suisses et le SOL-DHR (Service de suivi des donneurs vivants), avec titre, année et URL ? Quelles différences avec KDIGO 2017 et avec la recommandation européenne la plus récente (ERA-EDTA/ERBP) ? Citer la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL) ; comparer sa version la plus récente avec

celle citée dans le cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-026 — Haute — LOT 242 · SSP O7.20

Emplacement : LOT_242_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Partie 3 › DX.6 › fiche « Basiliximab » ; DX.7 › fiche complète et ® basiliximab

Contexte : Le cours dit que l'indication suisse de Simulect® se limite à la greffe rénale de novo ; adaptation hépatique et indication hépatique non trouvées.

Question : Selon l'information professionnelle suisse de Simulect® (date de révision), quelles sont l'indication autorisée, la dose (20 mg J0 et J4 ?), l'adaptation rénale et hépatique et l'usage en greffe hépatique (hors indication ?) ; quelles inductions utilisent les centres suisses en greffe hépatique ? Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-027 — Haute — LOT 242 · SSP O7.20

Emplacement : LOT_242_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Partie 3 › DX.7 › insuffisance hépatique aiguë : tableau d'interprétation (glycémie, SjvO2, PIC), fiche « Sérum salé hypertonique et mannitol », biopsie, pronostic

Contexte : Le cours cite EASL (glycémie cible ≈ 7,8 mmol/L, PIC > 25 mmHg, NaCl 2,7 % 200 mL ou mannitol 20 % 150 mL, osmolarité < 320 mOsm/L) ; seuil d'hypoglycémie, spécialités suisses, critères de guérison absents.

Question : Quelle est la recommandation européenne la plus récente sur l'insuffisance hépatique aiguë (EASL Clinical Practice Guidelines, version après 2017 ?) et existe-t-il un protocole suisse (centres de greffe hépatique, Swisstransplant) : seuil d'hypoglycémie à traiter, cibles de SjvO2 et de PIC, osmothérapie (concentrations et spécialités suisses du NaCl hypertonique et du mannitol), indications de la biopsie, critères de King's College et critères suisses d'inscription en urgence (score MELD, statut « urgence ») ? Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :

4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-028 — Haute — LOT 242 · SSP O7.20

Emplacement : LOT_242_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Partie 4 › DX.9 › cancers après transplantation (épidémiologie, surveillance, recommandations)

Contexte : Le cours cite STCS (6,2 % de cancers cutanés, PTLD 0,96 % à 5 ans) et KDIGO 2009, BCSH/BTS 2010, AST 2019 ; recommandations suisses non trouvées ; charge EBV sans seuil.

Question : Quelles recommandations suisses ou européennes récentes encadrent le dépistage des cancers cutanés du greffé (fréquence de l'examen dermatologique, photoprotection, conversion en inhibiteur de mTOR) et le PTLD (surveillance de la charge EBV : seuils, réduction de l'immunosuppression, rituximab) ? Comparer avec KDIGO 2009 et BCSH/BTS 2010. Citer la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL) ; comparer sa version la plus récente avec celle citée dans le cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-001 — Moyenne — LOT 242 · SSP O7.20

Emplacement : LOT_242_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Bloc 1 › point 2 (épidémiologie) › fenêtre « Profil des donneurs décédés en 2025 »

Contexte : Le tableau donne AVC/hémorragie cérébrale 37 % et 49 %, traumatisme crânien 16 % et 20 %, sans source vérifiée pour ces pourcentages.

Question : Quelle est la répartition des causes de décès des donneurs décédés utilisés en Suisse en 2025 (AVC/hémorragie cérébrale, traumatisme crânien, anoxie, autres), séparément pour le DBD et le DCD, selon le rapport annuel Swisstransplant 2025 (titre, page, URL) ? Comparer aux chiffres 2024 et indiquer à quoi correspondent les deux colonnes du cours. Donner le chiffre suisse le plus récent (source, année, URL : OFS, OFSP, registre ou rapport national) ; à défaut, le chiffre européen le plus récent avec sa méthode de mesure.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-003 — Moyenne — LOT 242 · SSP O7.20

Emplacement : LOT_242_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_242_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc 1 › fenêtre « état végétatif » ; Partie 2 › DX.3 › tableau « Notions voisines : coma, état végétatif, locked-in, mort cérébrale »

Contexte : Le cours décrit l'état végétatif comme un éveil sans conscience avec tronc cérébral fonctionnel ; définition clinique détaillée absente.

Question : Quelle définition clinique de l'état végétatif (syndrome d'éveil non répondant) et de l'état de conscience minimale retiennent les directives ASSM « Diagnostic de la mort dans le contexte de la transplantation d'organes » (version en vigueur et révision 2025) ou, à défaut, l'Academy of Neurology européenne (EAN 2020) ? Préciser les critères qui le distinguent de la mort cérébrale et du locked-in. Citer la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL) ; comparer sa version la plus récente avec celle citée dans le cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-006 — Moyenne — LOT 242 · SSP O7.20

Emplacement : LOT_242_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_242_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html ; LOT_242_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc 1 › 9.c alternatives (grossesse, DFGe, stimulateur) ; Partie 1 › fenêtre « examen technique d'absence de perfusion » ; Partie 2 › DX.3 et DX.4 › tableaux « Alternatives selon le contexte »

Contexte : Le cours ne sait pas quel examen complémentaire choisir chez la femme enceinte, si DFGe < 30 mL/min, en cas d'allergie aux produits de contraste iodés ou de stimulateur incompatible avec l'IRM.

Question : Quel examen complémentaire de l'arrêt de la perfusion cérébrale recommander, selon les directives ASSM ou les protocoles suisses (Swisstransplant/CNDO), chez la donneuse enceinte, en cas de DFGe < 30 mL/min, d'allergie aux produits de contraste iodés et de stimulateur cardiaque incompatible avec l'IRM ? Préciser si la grossesse modifie le diagnostic de mort ou la conduite (maintien somatique). Citer la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL) ; comparer sa version la plus récente avec celle citée dans le cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-015 — Moyenne — LOT 242 · SSP O7.20

Emplacement : LOT_242_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_242_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Bloc 1 › fenêtre « Entretien d'information avec le patient ou ses proches » ; Partie 1 › DX.2 › 7.3 syndrome « crainte et idées reçues » et fenêtre « aspects religieux »

Contexte : Le cours dit que l'appartenance religieuse ne doit pas empêcher d'aborder le don ; positions officielles des communautés religieuses suisses non trouvées (seules des organisations allemandes citées).

Question : Quelles positions officielles sur le don d'organes et la mort cérébrale ont publiées les communautés religieuses de Suisse (Conférence des évêques suisses, Église évangélique réformée de Suisse, Fédération suisse des communautés israélites, organisations islamiques faîtières) ou l'OFSP/Swisstransplant dans un document de synthèse (titre, année, URL) ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

FIN DU PAQUET HELP_Organi_P20 — 20 questions : E-002, E-004, E-005, E-008, E-010, E-011, E-013, E-014, E-017, E-018, E-019, E-020, E-023, E-026, E-027, E-028, E-001, E-003, E-006, E-015